

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	尿毒症 Uremia				
編號	A31000-Q03-W-E03	制定者	HD 林卉姍	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 11 月 21 日
版本/總頁數	第 4.1 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解尿毒症的定義、臨床表徵、常見檢查及治療、護理問題與措施及衛教指導，並使護理人員具有更適切之照護能力，以提升照護品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

當腎臟功能隨著腎臟組織的損傷而減低時，稱為腎功能不全，當腎功能僅存 5-10% 時，則會導致體內尿毒素及水份排出困難，造成體內尿毒素及水份堆積而產生全身性症狀即「腎衰竭」，俗稱為「尿毒症」。

（二）症狀

早期的尿毒症沒有顯著臨床表徵，而末期尿毒症常見症狀有疲倦、下肢水腫、尿量減少、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、貧血等。

（三）常見檢查

1. 血管攝影。
2. 腎臟超音波。
3. 血液檢查：尿素氮(BUN)、肌酸酐(Cr)、鉀離子(K⁺)、血色素(Hb)、血比容(Hct)。
4. 尿液檢查。
5. 腎臟切片。

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/8

(四) 常見治療

尿毒症在未接受腎臟替代治療前，可以靠血壓的控制和低蛋白質飲食減緩殘餘腎功能下降的速度及減輕尿毒症狀。當腎臟功能小於 10%時，則須接受腎臟替代療，腎臟替代治療方式如下：

- 1.血液透析。
- 2.腹膜透析。
- 3.腎臟移植。

(五) 護理問題

- 1.體液容積太多／攝入過多液體。
- 2.缺乏營養／少於身體需要。
- 3.易感染／抵抗力降低。
- 4.皮膚狀態不完整／皮膚搔癢。
- 5.排便異常：便秘／飲食習慣不良及藥物影響。
- 6.活動耐力不足／無法執行日常生活活動及活動無耐力。
- 7.口腔黏膜異常／疾病和維生素缺乏。
- 8.焦慮感受／對身體健康之威脅。

(六) 護理措施

1.體液容積太多／攝入過多液體

- (1)體液容積太多的矯正措施：藥物治療（如：利尿劑）、飲食控制、水份攝取限制（每日水份的攝取量為：前一天的總尿量加 500-600cc）及透析療法，護理人員應協助病人遵從這些治療措施。
- (2)經常觀察病人體液容積過量的徵象及症狀，並每日監測病人的體重（兩次透析間體重的增加應小於等於標準體重 5%）、輸出輸入量、血壓。
- (3)採限鈉飲食及限制水份攝取（每日水份的攝取量為：前一天的總尿量加 500-600cc），因攝取過多的鹽份會導致液體滯留，且病人易口渴，導致水份攝取過多。

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/8

(4) 監測並報告不正常的實驗數值或 X 光片結果，如：血清鈉離子、血尿素氮、PH、PaCO₂、血比容和胸部 X 光片。

2. 缺乏營養／少於身體需要

- (1) 衛教病人的飲食，未透析前採低蛋白、低鉀、低鈉、低磷及限制液體的攝取，並補充適當的維他命及礦物質，開始透析後則採高蛋白，低鉀、低鈉、低磷及限制液體的攝取。
- (2) 了解病人的飲食習慣及喜好，請病人記錄每日飲食內容，分析後與其和主要照顧者討論並給予適當的飲食衛教，如：少量多餐，教導增加攝取優質蛋白質食物，如：魚、豬肉、牛肉、奶類（腎臟病專用配方牛奶）等，可交替食用，增加病人的接受度。
- (3) 教導進食前、後口腔衛生的重要性，以加強對食物的味覺，進而能攝取更足夠的營養。

3. 易感染／抵抗力降低

- (1) 觀察病人有無泌尿道、上呼吸道和皮膚破損及血管通路感染的情形。
- (2) 進行任何侵入性治療時，應嚴格遵守無菌技術。
- (3) 教導病人透析管路若有任何感染徵象及症狀，如：紅、腫、熱、痛，應立即請醫師診治，勿任意自行服藥。
- (4) 每次透析時測量體溫，每月定時監測可顯示感染的檢查值，如：WBC、CRP。

4. 皮膚狀態不完整／皮膚搔癢

- (1) 避免皮膚摩擦與刺激，勿搔抓，以免越抓越癢及破皮引起感染。若癢的厲害，可用手按壓、冷敷或依醫囑使用止癢藥膏。
- (2) 若皮膚感覺乾燥及搔癢，可使用中性乳液及藥膏來潤滑皮膚減輕搔癢感。
- (3) 病人皮膚出現尿毒霜，可經常以溫水清洗，再以毛巾拍乾皮膚，清除皮膚上聚積的尿酸結晶。
- (4) 提供充分的透析治療，維持尿毒素清除率 > 1.2。
- (5) 透析治療時溫度調低到 35.5-36°C 之間。

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/8

(6)依醫囑調整磷結合劑的劑量，並教導磷結合劑服藥的正確方式（三餐的食物與藥物一起咬碎服用）。

(7)衛教病人攝取低磷飲食，避免食用高磷食物，如：鮮奶、奶粉、發酵食品、肉湯……等等。

5. 排便異常：便秘／飲食習慣不良及藥物影響

(1)注意觀察病人排便型態改變，依醫囑給予病人不含鎂的軟便劑，麥麩因含鉀、磷不多，可建議病人食用以減輕便秘。

(2)鼓勵病人維持規則之運動；協助計畫合適的運動。

(3)鼓勵病人飲食攝取均衡，增加高纖食物的攝取。

(4)依醫囑必要時給予軟便劑藥物使用。

6. 活動耐力不足／無法執行日常生活活動及活動無耐力

(1)尿毒症病人常因疲倦、貧血及營養不良等因素而造成缺乏活動力，並影響到自我照顧的執行，所以應協助病人獲得充足的睡眠及提高血色素；藥物補充時應注意之事項，如：口服鐵劑時不可與制酸劑同時服用；葉酸應在透析後給予。維持良好的睡眠及適當的休息；對於貧血者依醫囑給予紅血球生成素(EPO)及補充鐵(Fe)或葉酸(F.A)來治療貧血。

(2)評估病人目前活動及對活動的耐受力，教導病人活動時採漸進性及計畫性，避免過於疲勞，當活動中有不舒服，需立即停下活動，做適當之休息。

(3)教導病人及家屬如何增加自我照顧能力的方法，採漸進性且時間由短慢慢增加，必要時由家屬在旁協助，以增加病人信心。

7. 口腔黏膜異常／疾病和維生素缺乏

(1)經常給予口腔護理，特別是在進食後，嘴唇乾燥則可給予甘油或水溶性潤滑劑來減輕不適。

(2)評估病人口腔粘膜，包括：顏色、濕潤、有無病兆或潰瘍等。

(3)依醫囑給予綜合維生素藥物服用。

(4)依醫囑給予口腔黏膜潰瘍藥膏使用。

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/8

8. 焦慮感受／對身體健康之威脅

- (1) 護理人員應運用治療性溝通技巧，鼓勵病人說出其感受及擔心的事情，並給予病人適當的心理支持。
- (2) 解釋疾病過程說明各項檢查及治療程序時，應配合病人的教育程度及理解能力給予適當的說明，才能增加病人的了解及減低焦慮情形。
- (3) 介紹正向且規則血液透析病友與病人分享接受治療之心路歷程，降低病人的焦慮。

(七) 衛教指導

1. 泌尿道感染。
2. 尿毒症病人高血壓的控制。
3. 腎臟移植衛教手冊。
4. 血液透析治療的認識。
5. 血液透析病人日常生活的照顧。
6. 血液透析病人的飲食。
7. 血液透析病人的常規用藥。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王裕方、廖建富、陳瑋毅、戴有志、呂秉勳(2022)•尿毒搔癢症治療之系統性回饋•

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/8

台灣醫學，26(3)，271-286。

- (二) 李宜學、吳培甄、吳志仁(2021)・老年血液透析病人的營養與自我或家屬照護衛教・長庚護理，33(4)，187-191。
- (三) 吳紅蓮(2020)・慢性腎臟病病人維生素及礦物質之建議與補充・腎臟與透析，32(1)，44-49。
- (四) 陳慧芳、黃寶蓉(2021)・一位體液容積過量並不遵從治療之血液透析病人的護理經驗・源遠護理，15(3)，30-36。
- (五) 胡千逸、陳綉惠(2022)・運用 Swanson 關懷理論照顧一位不遵從血液透析病人之護理經驗・台灣腎護理學會雜誌，20(2)，73-86。
- (六) 葉淑敏、林育如、徐紫娟、張玉婷(2021)・運用自我管理策略控制血液透析病人透析間體重增加之改善方案・護理雜誌，68(5)，83-91。
- (七) 蔡美玲、戴培惠(2021)・一位血液透析病人不遵從透析醫囑之護理經驗・若瑟醫護雜誌，15(1)，70-82。
- (八) 鍾惠琴、鍾玉珠(2021)・協助一位初次血液透析患者建立長期透析生活之護理經驗・彰化護理，28(1)，96-107。
- (九) 龔柏仁、詹君美、劉又瑛(2020)・照護一位末期腎臟疾病人初次接受血液透析治療之護理經驗・台大護理，16(2)，29-40。
- (十) Hendriks, F. K., Smeets, J. S. J., Broers, N. J. H., van Kranenburg, J. M. X., van der Sande, F. M., Kooman, J. P., & van Loon, L. J. C., (2020). End-stage renal disease patients lose a substantial amount of amino acids during hemodialysis. The Journal of Nutrition, 150(5), 1160-1166. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

七、附件

(略)

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	1. 修改說明內容。 2. 修改錯別字。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1. 修改說明內容及標點符號。 2. 護理部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	新增護理措施：(1)每日水分的攝取量為：前一天的總尿量加 500-600 cc(2)兩次透析間體重的增加應小於等於標準體重 5%(3)每日水分的攝取量為：前一天的總尿量加 500-600 cc	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
103.08.31	3.2	參考資料文獻部份內容更新。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.06.02	3.3	1. 第三項說明內容部份修詞。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	新增參考文獻於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	1. 第三項第(三)、(四)目部份內容刪修。 2. 更新第六項參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.13	3.6	1. 第一項部份內容刪修。 2. 第三項第一、二、六目說明內容刪修。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過。

主題名稱	尿毒症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E03	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
107.09.12	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六目之 1(1)(3)、之 2(1)文字修訂；之 8 參考資料修訂。 3. 第六項第六目新增期刊名稱。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.8	1. 第三項第六、七目說明內容修訂。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.9	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	4.0	1. 第三項第五目、第六目護理問題修訂。 2. 參考資料文獻更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.11.21	4.1	第六項參考資料修訂。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.02	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	